

1 Hipótese Diagnóstica Funcional

Diagnóstico fisioterapêutico principal: Lombalgia crônica inespecífica com disfunção do controle motor segmentar lombar e componentes psicossociais associados (cinesiofobia — Tampa ≥ 45).

Diagnósticos diferenciais: Síndrome facetária L4-L5, Disfunção sacrílica unilateral, Hérnia discal pósterio-lateral L5-S1 (descartada por RM).

Fatores contribuintes: Sedentarismo ocupacional (8h/dia sentado), fraqueza de transverso abdominal e multífidos (espessura muscular reduzida ao US), catastrofização da dor (PCS = 32), padrão recrutamento muscular alterado (flexion-relaxation paradox ausente).

CIF — Classificação Internacional de Funcionalidade:

b28013 (2) — Dor no dorso, moderada

d4150 (2) — Manter a posição deitada, moderada

d410 (2) — Mudar posições básicas, moderada

d450 (1) — Andar, leve

b730 (1) — Funções de força muscular, leve

b152 (2) — Funções emocionais, moderada

2 Plano de Tratamento — Dividido em Fases

Fase 1 — Analgesia e Educação (Sessões 1-4)

2×/semana

2 semanas

Objetivos: Reduzir EVA para ≤ 4 , diminuir cinesiofobia (Tampa < 40), iniciar controle motor segmentar.

- **PNE** — Pain Neuroscience Education (Louw et al., 2023. *J Orthop Sports Phys Ther*. Nível: 1A). Sessão 1: neurofisiologia da dor. Sessão 2: dessensibilização central. Sessão 3: reconceitualização.
- **Ativação de transverso abdominal** em DDH com feedback tátil + US em tempo real (Hodges & Richardson, 1996. *Spine*. Nível: 2B). 3 séries $\times$ 10s sustentação, 10 repetições.
- **Mobilização PA grau I-II** em L4-L5 (Maitland conceito). 3 $\times$ 30s, ritmo 1Hz.
- **Respiração diafragmática** associada à ativação do assoalho pélvico (Hodges & Gandevia, 2000. Nível: 2B). 5 min, 2×/dia.

▶ **Critérios de progresso:** EVA ≤ 4 , paciente explica conceitos de PNE, ativação de TA sem compensação de oblíquos externos por ≥ 8 s.

Fase 2 — Controle Motor e Estabilização (Sessões 5–10)

 2×/semana

 3 semanas

Objetivos: Controle motor segmentar em cadeia cinética fechada, dissociação lombopélvica em posturas funcionais, EVA ≤ 2 .

- **Dead bug progressivo** (Evidence A — Cochrane Back Review, 2022). Nível 1: MMSS. Nível 2: MMII. Nível 3: contralateral (braço direito / perna esquerda). 3×10, sustentação 5s.
- **Ponte unilateral** com ativação de TA prévia. 3×8, sustentação 5s. Meta: ≥ 30 s sem compensação.
- **Pelve neutra em sedestação** — correção postural dinâmica, 10 repetições com feedback tátil e espelho.
- **Agachamento parcial (0–60°)** com haste + correção de valgo dinâmico (Escamilla et al., 2001. *J Orthop Sports Phys Ther*. Nível: 2B). 3×12.
- **Quadrupedânia** — elevação alternada de membros com pelve estável. 3×8 cada lado.

▶ **Critérios de progressão:** EVA ≤ 2 , Tampa ≤ 37 , ponte unilateral ≥ 30 s, agachamento 60° com pelve neutra, dead bug nível 3 completo sem perda de posição neutra.

Fase 3 — Carga Funcional e Retorno à Atividade (Sessões 11–16)

 1–2×/semana

 4 semanas

Objetivos: Tolerar cargas funcionais, preparar para alta com programa domiciliar autônomo, LSI $\geq 90\%$.

- **Levantamento terra romeno com halteres** (Berglund et al., 2015. *Br J Sports Med*. Nível: 1B). 3×8, 50% 1RM → progressão 5–10%/semana.
- **Agachamento frontal** — 3×8, 50% 1RM, progressão semanal.
- **Padrões de movimento:** carregar objeto do chão com técnica correta, rotação de tronco com carga controlada.
- **YOGA + alongamento dinâmico** — ênfase em flexão anterior de tronco controlada (postura criança → gato-vaca).

▶ **Critérios de progressão:** LSI $\geq 90\%$ em todos os testes funcionais, EVA ≤ 1 nas atividades da vida diária, paciente independente no programa domiciliar.

3 Resumo do Tratamento

TOTAL DE SESSÕES

16 sessões

FREQUÊNCIA

2× → 1–2×/sem

INTERVALO ENTRE SESSÕES

48–72 horas

DURAÇÃO TOTAL ESTIMADA

9 semanas

Justificativa: Intervalo de 48–72h entre sessões otimiza o aprendizado motor (consolidação da memória procedural) e permite recuperação tecidual adequada entre estímulos de carga (Schmidt & Lee, 2020. *Motor Control and Learning*. Nível: 1A). Frequência reduzida na Fase 3 visa transferência de responsabilidade para o paciente (programa domiciliar).

4 Critérios de Alta

- ✓ EVA ≤ 2 há pelo menos 2 semanas consecutivas
- ✓ LSI $\geq 90\%$ nos testes: *Y-Balance Test* anterior e posterolateral, *Single Hop for Distance*
- ✓ Tampa Scale of Kinesiophobia ≤ 37 (baixa cinesiofobia)
- ✓ Paciente independente no programa domiciliar ($\geq 80\%$ de adesão autorrelatada)
- ✓ Teste de levantamento do chão: execução com técnica adequada sem dor
- ✓ ODI $\leq 20\%$ (incapacidade mínima)

5 Escalas Funcionais Recomendadas

 **ODI** — Oswestry Disability Index
Pré, 4 sem, 8 sem, alta

 **Tampa Scale** — Kinesiophobia
Pré, pós-PNE (sessão 4), alta

 **PCS** — Pain Catastrophizing Scale
Pré, pós-PNE

 **GROC** — Global Rating of Change
Semanal

 **NPRS** — Numerical Pain Rating Scale
Toda sessão (pré/pós)

 **Y-Balance Test** — Controle neuromuscular
Alta (LSI)

6 Prognóstico

Expectativa de melhora: Favorável com adesão ao tratamento ativo.

- **4 semanas:** Redução de 50% da dor (EVA 6 $\rightarrow$ 3) — esperado com PNE + controle motor (Hicks et al., 2005. *Spine*. Nível: 1B)
- **8 semanas:** Retorno às AVDs sem limitação (ODI $\leq 20\%$)
- **9 semanas:** Alta com programa domiciliar consolidado

⚠ Fatores de risco para mau prognóstico: Tampa > 52 , dor > 6 meses, catastrofização alta (PCS > 30), presença de litígio trabalhista/previdenciário, baixa adesão ao programa domiciliar. Nestes casos, considerar encaminhamento para psicologia (terapia cognitivo-comportamental) e/ou programa multidisciplinar de dor crônica.

Recomendações ao paciente:

- Manter diário de dor (EVA matinal/noturna)
- Evitar repouso prolongado (> 2 dias) — movimento é analgesia

- Sinais de alerta para reavaliação: perda de força súbita em MMII, parestesia em sela, incontinência urinária/fecal, febre + dor lombar (red flags)
- Praticar exercícios domiciliares 10 min/dia (respiração diafragmática + ativação TA)

Referências Citadas

- Berglund et al. (2015). "Progressive resistance training in chronic low back pain". Br J Sports Med. Nível: 1B
 - Hicks et al. (2005). "Predictors of success with stabilization exercises". Spine. Nível: 1B
 - Hodges & Richardson (1996). "Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine". Spine. Nível: 2B
 - Louw et al. (2023). "Pain neuroscience education for chronic pain". J Orthop Sports Phys Ther. Nível: 1A
 - Cochrane Back Review Group (2022). "Exercise therapy for chronic low back pain". Cochrane Database. Nível: 1A
-

SASYRA — Sistema de Assistência e Análise em Saúde

Análise gerada por IA baseada em evidências | Documento gerado em 01/07/2026 14:32

Esta análise não substitui avaliação clínica presencial. O plano deve ser adaptado à resposta individual do paciente.

💡 Clique no botão acima ou pressione Ctr1+P e selecione "Salvar como PDF" para gerar o arquivo. Esta é uma **amostra simulada** do formato que a IA passará a gerar após as melhorias no prompt.